



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN II
KOMITE PPRA
BULAN APRIL – JUNI
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Triwulan II Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sehingga dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika).

Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba dilakukan berdasarkan tersedianya data audit penggunaan antibiotik. Data yang tersedia yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling berkesinambungan untuk dapat menilai apakah penggunaan antibiotik Rumah Sakit sudah tergolong rasional atau tidak. Hasil audit kuantitatif dan kualitatif dapat dijadikan penilaian terhadap seluruh SMF terkait pemberian antibiotik didasarkan pada PPAB (Panduan Penggunaan Antibiotik).

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba ini, kami mengucapkan terima kasih kepada komite yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini :

Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	April - Juni	Kebutuhan	
Ketua PPRA	1	1	0	
Sekretaris	1	1	0	
Anggota	15	15	0	

II. Pemenuhan kualifikasi SDM

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan	Keterangan
		Standar	Kondisi saat ini		
Ketua	dr. Brilliant Margalin, Sp.PK,MARS	S1	Spesialis Patologi Klinik	Pelatihan PPRA Eksternal	Terlaksana
Sekretaris	apt. Nur Intan Permatasari, S.Farm.	S1	Apoteker	Pelatihan PPRA Eksternal	Terlaksana
Anggota	dr. Dimas Aryo P, Sp.PD	S1	Dokter Spesialis	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	dr. Djanuar Fitriadi, Sp.B	S1	Dokter Spesialis	Belum terlaksana	Belum terlaksana
	dr. I Gede Made Oka, Sp.OT	S1	Dokter Spesialis	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	S1	Dokter Spesialis	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	dr. Muhammad Irawan, Sp.A	S1	Dokter Spesialis	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	Rizki Dwi Ramadhani, Amd.Kep	S1/D3	Perawat	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	apt, Laili Choirul Ummah, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	apt, Ramadhan Rizki P, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	Elza Safarina Ulfa, Amd.Kes	S1/D3	Laboratorium	<i>In house training</i>	Terlaksana

				tahun 2024	
	Aulya Wahyuningrum Amd.Kes	S1/D3	Laboratorium	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.Ners	S1	Komite PPI	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	Lidia Puspita Kencana, S.KM	S1	Komite Mutu	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	dr. Adhya Aji Pratama, SP.PD	S1	Dokter Spesialis	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana
	apt. Dita Nur Aini, S.Farm	S1	Apoteker	<i>In house training</i> tahun 2024	Terlaksana

III. Program Kerja dan Pengembangan Pelayanan

No.	Kegiatan pokok	Rincian Kegiatan
1.	Peningkatan pemahaman mengenai PPRA kepada seluruh tenaga kesehatan dan staff rumah sakit.	- Sosialisasi terkait penggunaan antibiotik secara bijak kepada perawat dan bidan RS Prima Husada Sukorejo - Sosialisasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak serta program kerja PPRA kepada staff farmasi RS Prima Husada Sukorejo - Sosialisasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak kepada pasien dan keluarga pasien (rawat inap dan rawat jalan) - Sosialisasi penggunaan antibiotik yang bijak kepada masyarakat melalui media sosial RS Prima Husada Sukorejo
2.	Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)	- Menerapkan sistem daftar antibiotik terbatas - Mewajibkan pengisian formulir PGA (G-Form) sebelum peresepan antibiotik tertentu - Melakukan audit dan feedback berkala terkait pola peresepan antimikroba.

3.	Surveilans penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif	- Mengumpulkan data pemakaian antibiotik dari farmasi, rekam medis, dan SIMRS berdasarkan jenis, jumlah, dan unit pelayanan. - Analisis penggunaan antibiotic secara kuantitatif (DDD/100 <i>patient days</i>) dan kualitatif (audit ketepatan indikasi, dosis, durasi) - Menganalisis pola penggunaan antibiotik berdasarkan golongan dan jenis antibiotik. - Menyusun laporan tren penggunaan antibiotik per bulan - Melakukan evaluasi kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai panduan klinis
4.	Surveilans resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO	- Melakukan pemantauan terhadap kejadian infeksi oleh mikroorganisme resisten (MDRO), seperti ESBL dan MRSA. - Untuk laboratorium yang belum dapat mengidentifikasi ESBL/MRSA, tetap memantau MDR - Mengintegrasikan data resistensi dengan data klinis untuk mendukung pengambilan keputusan terapi.
5.	Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi	- Menentukan kasus infeksi yang akan dikaji, terutama kasus dengan penggunaan antibiotik spektrum luas, multidrug - Mengumpulkan data rekam medis, hasil laboratorium, kultur dan uji sensitivitas, terapi antibiotik, serta perkembangan klinis pasien. - Persiapan forum kajian kasus dan Menyelenggarakan forum kajian kasus terintegrasi (FORKKIT). - Melibatkan dokter klinis, apoteker, mikrobiologi, dan perawat dalam diskusi kasus. - Merumuskan perbaikan tata laksana infeksi dari hasil FORRKIT dan memasukkan ke dalam kebijakan rumah sakit

IV. Fasilitas

No.	Kegiatan Pokok	Keterangan
1	Ruang Komite PPRA	Mengajukan ke pihak manajemen

V. Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien PPRA

No.	Indikator Mutu	Standar
1	Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada	-
2	Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)	≥50%
3	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika	-
4	Audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif	-

VI. PENCAPAIAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA TRIWULAN II

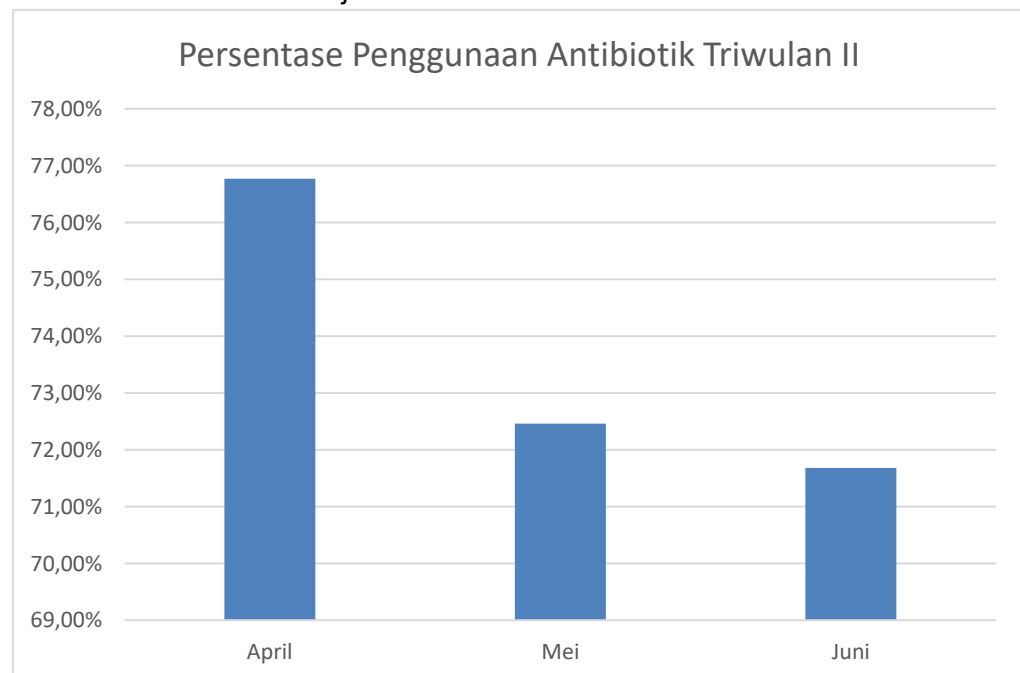
6.1 Hasil Surveilans audit Kualitatif dan Kuantitatif PPRA Triwulan II

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo

a. Tabel Surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo

No.	Bulan	Persentase
1	April	76,77 %
2	Mei	72,46 %
3	Juni	71,68 %

b. Grafik surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo



Gambar 1. Grafik Penggunaan Antibiotik Triwulan II

Berdasarkan Persentase Penggunaan Antibiotik Triwulan II (April - Juni), terlihat bahwa penggunaan antibiotik mengalami tren penurunan selama periode tersebut. Pada bulan April, persentase penggunaan antibiotik mencapai sekitar 76,8%, kemudian menurun menjadi sekitar 72,4% pada bulan Mei, dan kembali menurun menjadi sekitar 71,7% pada bulan Juni.

Secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar kurang lebih 5,1% dari April hingga Juni. Penurunan yang cukup signifikan terjadi antara bulan April dan Mei, sedangkan penurunan dari Mei ke Juni relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengendalian penggunaan antibiotik yang mulai memberikan hasil selama Triwulan II.

c. Analisa surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS PrimaHusada Sukorejo

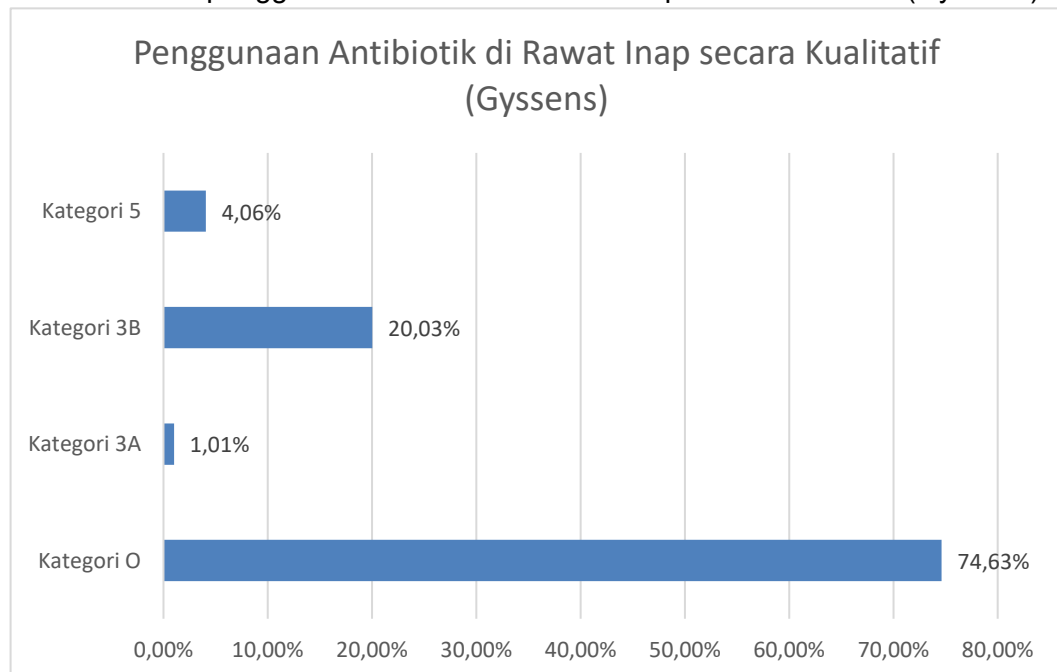
- Penggunaan antibiotik menunjukkan kecenderungan menurun dari bulan ke bulan.
- April merupakan bulan dengan persentase penggunaan antibiotik tertinggi (76,8%), sedangkan Juni merupakan yang terendah (71,7%).
- Penurunan ini dapat mengindikasikan bahwa implementasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA), audit penggunaan antibiotik dan penerapan penatagunaan antimikroba (Antimicrobial Stewardship Program) mulai berjalan efektif.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik berpotensi mengurangi penggunaan yang tidak rasional.
- Berkurangnya kasus infeksi yang memerlukan terapi antibiotik pada periode tertentu.
- Penurunan penggunaan antibiotik harus tetap diimbangi dengan pemantauan luaran klinis pasien agar tidak terjadi underuse antibiotik.
- Perlu dilakukan evaluasi jenis antibiotik yang digunakan (Access, Watch, Reserve), kepatuhan pengisian G-Form, serta audit kualitatif penggunaan antibiotik untuk memastikan bahwa penurunan penggunaan tetap sesuai indikasi klinis.

2. Audit penggunaan antibiotika di Rawat Inap secara kualitatif (Gyssens)

a. Tabel audit penggunaan antibiotika di Rawat Inap secara kualitatif (Gyssens)

No	Kriteria Gyssens	Standar	%
			April - Juni
1	Katagori 0	≥ 50	74,63 %
2	Katagori 1	0	0
3	Katagori 2A	0	0
4	Katagori 2B	0	0
5	Katagori 2C	0	0
6	Katagori 3A	0	1,01 %
7	Kategori 3B	0	20,3 %
8	Kategori 4	0	0
9	Kategori 5	0	4,06 %
10	Kategori 6	0	0

b. Grafik audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara Kualitatif (Gyssens)



Gambar 2. Grafik penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara Kualitatif (Gyssens)

Berdasarkan hasil evaluasi kualitatif penggunaan antibiotik menggunakan metode Gyssens periode April - Juni 2026, diperoleh bahwa sebagian besar penggunaan antibiotik telah memenuhi kriteria rasional (Kategori 0) sebesar 74,63%, melampaui standar yang ditetapkan yaitu $\geq 50\%$.

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas persepsan antibiotik di rumah sakit telah sesuai dengan indikasi, pemilihan jenis antibiotik, dosis, interval, rute, dan lama pemberian yang tepat. Tidak ditemukan kasus yang termasuk dalam Kategori I, IIA, IIB, IIC, IV, dan VI (0%), yang menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan terkait waktu pemberian, dosis, interval, rute pemberian, maupun ketidaklengkapan data yang menghambat penilaian.

Namun demikian, masih ditemukan penggunaan antibiotik yang belum rasional pada beberapa kategori. Kategori IIIA sebesar 1,01% menunjukkan adanya penggunaan antibiotik dengan durasi terapi yang lebih lama dari yang seharusnya. Sementara itu, Kategori IIIB merupakan temuan terbesar dari ketidaksesuaian penggunaan antibiotik yaitu sebesar 20,3%, yang menunjukkan terdapat penggunaan antibiotik dengan durasi terapi yang terlalu singkat dibandingkan rekomendasi yang berlaku. Selain itu, ditemukan Kategori V sebesar 4,06%, yang mengindikasikan adanya pemberian antibiotik tanpa indikasi yang jelas atau tidak diperlukan berdasarkan kondisi klinis pasien.

c. Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)

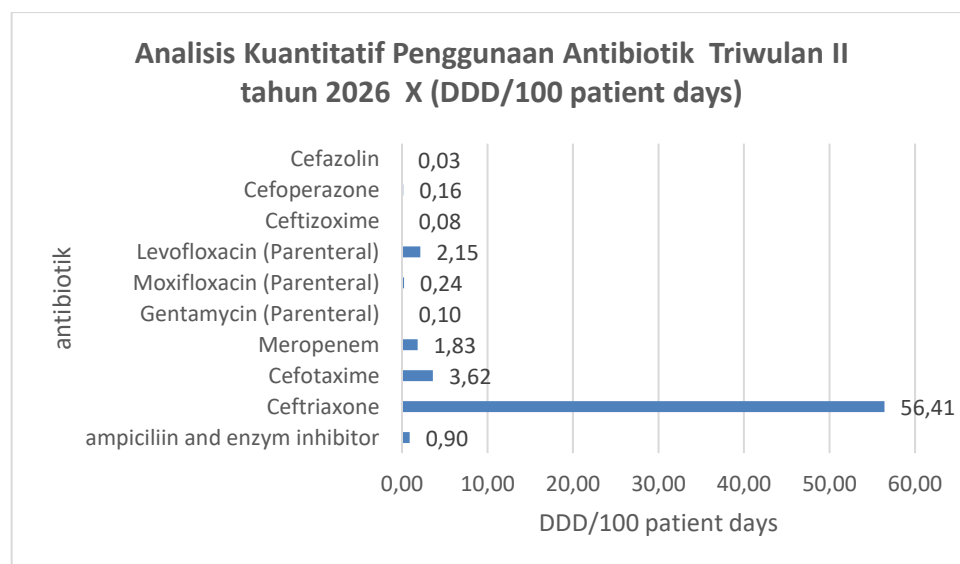
1. Kategori IIIB (20,3%) merupakan masalah utama
 - Dari hasil penggunaan antibiotik secara kualitatif didapatkan tingginya kategori ini menunjukkan masih banyak terapi penggunaan antibiotik yang dihentikan lebih cepat dari durasi yang direkomendasikan.
 - Kondisi ini berpotensi menyebabkan kegagalan terapi, kekambuhan infeksi, serta meningkatkan risiko terjadinya resistensi antimikroba.
2. Kategori V (4,06%)
 - Masih terdapat pemberian antibiotik pada kasus yang tidak memiliki indikasi infeksi bakteri yang jelas.
 - Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan ketepatan diagnosis sebelum pemberian antibiotik, terutama pada kasus infeksi virus seperti dengue, campak, atau penyakit non-infeksi.
3. Kategori III A (1,01%)
 - Masih ditemukan penggunaan antibiotik yang melebihi durasi terapi yang dianjurkan.
 - Penggunaan antibiotik yang terlalu lama dapat meningkatkan risiko resistensi, efek samping obat, serta pemborosan biaya pengobatan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Tingginya kasus Gyssens Kategori IIIB (20,3%) dan Masih ditemukan penggunaan antibiotik tanpa indikasi (Kategori V 4,06%). 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap penerapan PPAB, terutama pada penggunaan antibiotik kategori <i>Watch</i> dan <i>Reserve</i>. 3. Memberikan feedback kepada DPJP terkait hasil audit. 4. Optimalisasi pengisian G-Form Antibiotik.	1. Sosialisasi PPAB dilakukan kepada DPJP 2. Pelaksanaan audit prospektif antibiotik oleh Tim PPRA. 3. Pemberian rekomendasi penghentian terapi antibiotik berkepanjangan.	Kepatuhan pengisian G-Form.	Integrasi sistem peringatan durasi terapi antibiotik berkepanjangan.

- d. Tabel audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara kuantitatif Triwulan II (April - Juni)

No.	Kode DDD	Nama Antibiotik	Tot DDD	Tot DDD/rawat inap*100
1	J01CR01	ampiciliin and enzym inhibitor	11,31	0,90
2	J01DD04	Ceftriaxone	709,70	56,41
3	J01DD01	Cefotaxime	45,55	3,62
4	J01DH02	Meropenem	23,00	1,83
5	JO1GB03	Gentamycin (Parenteral)	1,25	0,10
6	J01MA14	Moxifloxacin (Parenteral)	3,00	0,24
7	J01MA12	Levofloxacin (Parenteral)	27,00	2,15
8	J01DD07	Ceftizoxime	1,00	0,08
9	J01DD12	Cefoperazone	2,00	0,16
10	J01DB04	Cefazolin	0,33	0,03
JUMLAH			823,81	65,49



Grafik audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara kuantitatif triwulan II

- e. Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif penggunaan antibiotik di ruang rawat inap selama Triwulan II Tahun 2026, diperoleh total konsumsi antibiotik yang diukur menggunakan indikator DDD/100 patient days. Antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Ceftriaxone dengan nilai 56,41 DDD/100 patient days, jauh lebih tinggi dibandingkan antibiotik lainnya. Penggunaan berikutnya adalah Cefotaxime sebesar 3,62 DDD/100 patient days, Levofloxacin parenteral sebesar 2,15 DDD/100 patient days, dan Meropenem sebesar 1,83 DDD/100 patient days.

Antibiotik lain yang digunakan dalam jumlah lebih rendah antara lain Ampicillin dan enzim inhibitor sebesar 0,90 DDD/100 patient days, Moxifloxacin parenteral sebesar 0,24 DDD/100 patient days, Cefoperazone sebesar 0,16 DDD/100 patient days, Gentamycin parenteral sebesar 0,10 DDD/100 patient days, Ceftizoxime sebesar 0,08 DDD/100 patient days, dan Cefazolin sebesar 0,03 DDD/100 patient days. Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, sehingga perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
Identifikasi Masalah :			
Hasil audit kuantitatif Triwulan II menunjukkan penggunaan Ceftriaxone sangat dominan yaitu 709,70 DDD (56,41 DDD/100 patient-days), jauh lebih tinggi dibanding antibiotik lainnya.	-Melakukan audit penggunaan Ceftriaxone pada pasien rawat inap. -Mengoptimalkan pelaksanaan pra-otorisasi antibiotik dan pengisian formulir permintaan antibiotik.	- Perhitungan DDD antibiotik triwulan berikutnya. - Rekapitulasi formulir evaluasi antibiotik.	- Mempertahankan program audit dan umpan balik rutin. - Menjadikan evaluasi antibiotik 48–72 jam sebagai standar penlayana.
Akar masalah yang terjadi: - Kebiasaan klinisi menggunakan Ceftriaxone sebagai terapi utama - Kurangnya pemeriksaan kultur & uji sensitivitas - Monitoring PPRA belum maksimal Rencana intervensi: - Sosialisasi pedoman penggunaan antibiotik - Pembatasan penggunaan Ceftriaxone (restriksi/justifikasi) - Audit penggunaan antibiotik (DDD dan kualitatif) - Optimalisasi pemeriksaan kultur - Feedback ke DPJP/unit	- Implementasi form persetujuan antibiotik tertentu - Monitoring oleh Tim PPRA - Diskusi kasus infeksi (<i>clinical meeting</i>)	Evaluasi dilakukan dengan: - Membandingkan data DDD periode berikutnya - Melihat tren: • Penurunan penggunaan ceftriaxone • Evaluasi kesesuaian indikasi, dosis dan durasi Indikator keberhasilan: - Penurunan total DDD jika overuse terjadi	- Penguatan regulasi (SK Direktur) - Pengembangan sistem IT (alert penggunaan antibiotik)

VII. KESIMPULAN

1. Hasil audit kuantitatif menunjukkan total penggunaan antibiotik rawat inap Triwulan II Tahun 2026 sebesar 65,49 DDD/100 patient-days.
2. Ceftriaxone merupakan antibiotik yang paling banyak digunakan dengan nilai 56,41 DDD/100 *patient-days*, sehingga menjadi fokus utama monitoring dan evaluasi Komite PPRA.
3. Hasil audit kualitatif metode Gyssens menunjukkan 74,63% penggunaan antibiotik telah rasional (Kategori 0).
4. Ketidaksesuaian penggunaan antibiotik masih ditemukan pada:
 - a. Kategori 3A sebesar 1,01% (durasi terapi terlalu lama),
 - b. Kategori 3B sebesar 20,3% (durasi terapi terlalu singkat),
 - c. Kategori 5 sebesar 4,06% (pemberian tanpa indikasi yang jelas).
5. Secara umum penggunaan antibiotik di rawat inap sudah cukup baik, namun perlu dilakukan peningkatan kepatuhan terhadap pedoman terapi terutama terkait evaluasi durasi pemberian antibiotik, pelaksanaan kultur mikrobiologi, de-eskalasi terapi, dan pengendalian penggunaan Ceftriaxone sebagai antibiotik yang paling dominan digunakan.
6. Komite PPRA perlu melanjutkan kegiatan audit, umpan balik kepada DPJP, serta edukasi penggunaan antibiotik rasional guna meningkatkan kualitas pelayanan dan menekan risiko resistensi antimikroba di rumah sakit.

Pasuruan, 05 Juli 2026

Penyusun,
Ketua Komite PPRA



dr. Brilliant Margalin, Sp.PK,MARS

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kes